

1. Fosa nazala are 4 pereti

- a. Inf (bolta), medial (septul), sup(cornetele si meatele), lat(planseul)
- b. Inf(planseul), medial(cornetele si meatele), lat(bolta), sup(septul)
- c. Inf (planseul), sup(bolta), medial (septul) lat (cornetele si meatele)**
- d. Inf (septul), sup (bolta), medial (planseul), lat(cornetele si meatele)
- e. Inf (cornetele si meatele), sup (bolta), medial (septul), lat (cornetele si meatele)

2. Etajul supraglotic nu contine

- a. Fata laringiana a epiglotei
- b. Benzile ventriculare
- c. Corzile vocale**
- d. Aritenoizii
- e. Repliurile aritenoepiglotice

3. Sinusul maxilar

- a. Dreneaza in meatul nazal mij**
- b. Nu este cel mai mare dintre sinusuri
- c. Se puncioneaza explorator sau therapeutic in meatul mij
- d. Dreneaza in meatul nazal inf
- e. Dreneaza in meatul nazal sup

4. Faciesul adenoidian se caracterizeaza prin urm, cu exceptia

- a. Gura deschisa
- b. Nas mic
- c. Fata congestionata cu privire pierduta**
- d. Buza sup retractata
- e. Buza inf inerta

5. Diagnosticul de tumora maligna a rinofaringelui se pune cu certitudinea prin :

- a. Anamneza
- b. Eco cervicala
- c. Radiografie pulmonara
- d. Ekg
- e. Biopsie din rinofaringe**

6. Colectia de sange localizata intre pericondul septal si cartilajul patrat

- a. Hematom septal**
- b. Hematom sinusal
- c. Luxatia piramidei nazale
- d. Fractura piramidei nazale

e. Hemangiom

7. Urmatoarele sunt cauze locale ale epistaxisului, cu exceptia

- a. Traumatismele piramidei nazale
- b. Rinite acute si cornice
- c. Polipul sangerand al septului nazal
- d. Rinofima**
- e. Tumori maligne nazo-sinusale

8. Adenoidita acuta este inflamatie acuta a:

- a. Amigdalei linguale
- b. Amigdalei palatine
- c. Amigdalei Luschka**
- d. Amigdala GerlInch
- e. Amigdala orofaringiana

9. Tratamentul de electie al colesteatomului este:

- a. Chirurgical**
- b. Antibiot terapie
- c. Radioterapie
- d. Chimioterapie
- e. Fizioterapie

10. Laringele:

- a. Este un organ fibro-muscular cartilaginous
- b. Este impartit in 3 etaje : supraglotic, glotic, subglottic
- c. Se continua cu traheea
- d. Este format dintr-un cartilaj elastic, epiglota
- e. Toate rasp sunt corecte**

11. Care din urmatoarele laringite cornice este specifica:

- a. Catarala
- b. Hipertrofica alba
- c. Sifilis**
- d. Atrofica
- e. Hipertrofica rosie

12. Urmatoarele afirmatii referitoare la TBC laringiana sunt adevarate cu exceptia:

- a. Este secundara TBC pulmonare
- b. Insamantarea B Koch se face prin sputa traheobronsica sau prin calea hematogena
- c. Varsta de predilectie este dupa 60 de ani**

- d. Tratamentul este specific si se efectueaza in reseaua de specialitate
- e. Varsta de predilectie este intre 20-40

13. Principalul simptom clinic in otoseferoza este

- a. Hipoacuzia de perceptie
- b. Vertij
- c. Tinnitus
- d. Hipoacuzia de transmisie**
- e. Senzatie de plenitudine auriculara

14. Unul dintre urmatoarele nu este cauza de surditate dobandita:

- a. Tratamentul cu chinina
- b. Anemia**
- c. Meningita
- d. Parotidita epidemica
- e. Tratamentul cu Kanamicina

15. In surditatea brusc instalata timpanul este:

- a. Perforat cu secretii prulente
- b. Congestionat
- c. Normal**
- d. Cu vezicule
- e. Bombat

16. Laringele este format din :

- a. Cartilajul tiroid**
- b. Cartilajul cricoid**
- c. Cartilajele aritenoid**
- d. Epiglota**
- e. Amigdalele palatine

17. Etajele laringelui sunt:

- a. Glotic**
- b. Lateral
- c. Supraglotic**
- d. Posterior
- e. Subglotic**

18. Peretele superior al foselor nazale e format din

- a. **Osul nazal**
- b. **Frontal**
- c. **Etmoidal**
- d. Temporal
- e. **Sfenoid**

19. Formele anatomoclinice ale epistaxisului sunt:

- a. **Anterior**
- b. Hipertensiv
- c. Diabetic
- d. **Posterior**
- e. Unilateral

20. Doua dintre urmatoarele variante sunt tumori maligne de oro/bucofaringe:

- a. **Cancerul amigdalei palatine**
- b. **Cancerul de lueta**
- c. Angiofibromul nazofaringian
- d. Tumora de rinofaringe
- e. Lipomul faringian

21. Cancerul amigdalei palatine

- a. **Este cea mai frecventa tumora a faringelui (nuilateral)**
- b. **Bucofaringoscopia este examenul prin care se pune in evidenta**
- c. **Ex HP ne pune diagnosticul de certitudine**
- d. Imunoterapia este tratamentul de baza
- e. Reprezinta cancer hipofaringian

22. Diagnosticul diferential al imperforatiei coanale se face cu:

- a. **Corpul strain nazal**
- b. Despicaturile velo-palatine
- c. **Adenoidita acuta**
- d. **Polipoza nazala**
- e. **Tumori maligne nazo-sinusale**

23. Cavitata bucala este delimitata de:

- a. **Anterior de buze**
- b. **Posterior de valul palatin**

- c. Inferior de palatul osos cu osul palatin
- d. Superior de planseul bucal
- e. Nici o afirmatie nu este adevarata

24. Amigdala rinofaringiana:

- a. Este situata in hipofaringe
- b. Este denumita ca amigdala lui Luschka**
- c. Este situata pe peretele superior si posterior al rinofaringelui**
- d. E alcatuita din tesut limfoid**
- e. Blocheaza sinusul piriform

25. Pe care din urmatoarele se pune diagnosticul pozitiv de TBC laringian

- a. Stari febrile, subfebrile**
- b. IDR la PPD**
- c. Bucofaringoscopie
- d. Rinoscopie anterioara
- e. Examenul bacteriologic al sputei**

26. Printre simptomele cancerului amigdalian se numara:

- a. Odinofagia**
- b. Disfagia**
- c. Scaderea ponderala**
- d. Epistaxisuri repetate
- e. Obstructie nazala progresiva

27. Diagnosticul tumorii glomice se pune pe urmatoarele elemente

- a. Surditate de transmisie ce poate deveni de perceptie**
- b. Acufene niciodata sincrone cu pulsul
- c. Vertijul si otalgia moderate, intermitente**
- d. Polipi aparuti in CAE carnosi, rosiatici, sangereaza la atingere si spontan**
- e. Paralizia nervului facial apare frecvent**

28. Amigdalita cronica

- a. inflamatie cronica a amigdalelor palatine insotita de hiperplazia tuturor elementelor din structura si prezenta de cazeum in interiorul criptelor**
- b. Factori favorizanti: amigdalite acute repetate in copilarie, adenoidite acute repetate, adenoidita cronica, imunitate mai scazuta a organismului**
- c. Forme clinice: atrofica, hipertrofica (la copii predomina hipertrofia de tesut limfoid- consistenta moale; la adulti predomina hipertrofia tesutului conjunctiv)**

- d. Se recomanda antibioterapie orala sau sistemica
- e. **Bucofaringoscopia: secretii purulente care se scurg pe peretele posterior al bucofaringelui; amigdale hipertrofice sau atrofile cu cazeum in cripte**

29. Din anginele acute in unele afectiuni hematologice fac parte:

- a. Angina eritemato-pultacee
- b. **Angina leucemica**
- c. Angina din zona zoster
- d. Angina aftoasa
- e. **Angina agranulocitara**

30. Tratamentul in epistaxis cuprinde:

- a. **Tratamentul cauzei care a generat sangerarea**
- b. Alimentatia orala
- c. **Oprirea hemoragiei**
- d. **Tratamentul simptomatic**
- e. Doar reechilibrarea starii generale

31. Angina eritemato-pultacee

- a. **Agentul etiologic este streptococul beta hemolitic**
- b. Agentul etiologic sunt sunt bacili fusiformi
- c. Nu apare niciodata adenita submandibulara
- d. **Se administreaza penicilina, eritromicina sau amoxicilina**
- e. ASLO nu este modificat

32. Inflammatory cronice specifice sifilisului faringelui:

- a. **Etiologie: treponema pallidum**
- b. **Faze clinice: primara, secundara, tertiara**
- c. **Sifilis congenital, dobandit**
- d. Sifilisul primar: forma anginoasa(febra, odinofagie, amigdale bilateral marite de volum, rosii, indurate, adenopatie satelita)
- e. Sifilisul primar: RBW pozitiv – dupa 4-5 sapt de la debutul fazei primare reprezinta perioada de contagiozitate maxima

33. Cauzele locale care pot determina hemoragie nazala sunt:

- a. **Perforatii septale**
- b. **Corpi straini nazali**
- c. Faringita cronica
- d. **Fibromul nazofaringian**

- e. Sinuzitele acute

34. Trei din urmatoarele variante sunt tumori maligne de oro/bucofaringe:

- a. Cancerul amigdalei palatine**
- b. Cancerul valului palatin
- c. Cancerul de baza de limba
- d. Cancerul de sinus piriform**
- e. Cancerul de cavum**

35. Corzile vocale:

- a. Au rol in fonatie**
- b. Sunt situate in etajul subglotic
- c. Fata lor superioara constituie planseul ventricolului Morganii
- d. Sunt situate in etajul supraglotic
- e. Sunt situate in etajul glotic**

36. Inervatia laringelui e asigurata de

- a. Nervul pneumogastric**
- b. Nervul accesoriu
- c. Nervii recurenti**
- d. Nervii laringieni superiori**
- e. Nervii XII

37. Hemostaza in epistaxis se realizeaza prin:

- a. Compresiunea digitala pe aripa nazala**
- b. Cauterizarea petei vasculare cu perla de nitrat de argint**
- c. Tamponamentul anterior**
- d. Aplicarea de comprese reci pe fosele nazale
- e. Tamponamentul posterior**

38. TBC faringelui:

- a. Secundara TBC pulmonare**
- b. Forme clinice: TBC miliara acuta (Isambert), TBC ulcerocazeoasa, forma latentă, lupusul faringelui, abcesul retrofaringian**
- c. TBC miliara acuta-apare la tineri cu TBC pulmonara cavitara, străe febrila 39-40, astenie marcata, transpiratii, pierdere in greutate, odinofagie, disfagie marcata, sialoree, inapetenta**
- d. Apar leziuni profunde distructive, nedureroase
- e. Se descriu 4 stadii(crudităte, ramolire, stadiul de ulceratie, cicatrizare)

39. Care din urmatoarele reprezinta cauze genrale de epistaxis

- a. **HTA**
- b. Rinitele acute si cronice
- c. **Afectiunile hematologice**
- d. **Boli infectioase acute**
- e. Sarcina

40. Formele anatomo-clinice ale epistaxis in functie de sediul sangerarii sunt urmatoarele

- a. Laterală
- b. **Anterioara**
- c. Secundara
- d. **Posterioara**
- e. Primitiva

41. Rinitele acute nespecifice

- a. **Rinite acute banale: coriza sau guturaiul**
- b. Rinitele septice ale adultului
- c. **Rinita infectioasa cu stafilococ auriu**
- d. **Rinita streptococica**
- e. **Rinita pseudomembranoasa (streptococ, pneumococ)**

42. Tumorile benigne ale laringelui sunt:

- a. **Nodulii vocali**
- b. **Polipii laringieni**
- c. Carcinomul scuamocelular
- d. **Hemangiomul**
- e. Laringita difterica

43. Bolnavul cu abces septal prezinta

- a. **Dureri locale**
- b. **Febra 36-37**
- c. Epistaxis
- d. **Cefalee**
- e. Disfagie

44. Fibromul nazofaringian

- a. **Apare predominant la sexul masculin fiind considerata tumora pubertatii masculine**
- b. **Etiologia frecvent incriminata e cea endocrina**
- c. **Dozarea a 17 cetosteroizilor arata surplus, tumora se dezvoltă pana in 20 de ani**
- d. **Epistaxisuri repetate la bolnavi de sex masculin in perioada de pubertate**
- e. Obstructie nazala rapida

45. Tumorile maligne ale cavumului

- a. **Ipoteza originii virotice e tot mai frecvent intalnita (virusul Epstein-Barr)**
- b. **Forme anatmopatologice: epitelioame 85-95% (nediferentiate, putin diferite, diferite)**
- c. **Faza de stare prezinta 5 forme: rinologica, otologica, neurologica, oftalmica, ganglionara**
- d. Faza otologica cuprinde: acufene, autofonie, hipoacuzie de perceptie, otite catarale cronice rebele la tratament, uneori otite acute
- e. Faza ganglionara(adenopatie cervicala inalta sau in spatiul dintre varful mastoidei si ramura verticala a mandibulei) se prezinta ca un bloc ganglionar de consistenta moale, nefixat, dureros la palpare

46. Malformatiile laringelui sunt reprezentate de

- a. Traheostomie
- b. **Laringomalacie**
- c. **Laringocel**
- d. **Membrana palmata**
- e. Piocel

47. Boala Meniere se caracterizeaza prin:

- a. **Debut brusc**
- b. **Vertij de tip rotator**
- c. **Acufene**
- d. **Hipoacuzie de perceptie imediat urmata de revenirea lenta a auzului**
- e. Otoree fetida

48. Care din urmatoarele nu reprezinta rinite acute specifice:

- a. Rinita scarlatinoasa
- b. **Rinita acuta banala**
- c. Rinita difterica
- d. **Rinita streptococica**
- e. Rinita rujeolica

49. In sifilisul primar bolnavul poate prezenta:

- a. **Hipoacuzie de perceptie**
- b. Otoree fetida
- c. **Acufene**
- d. Hipoacuzie de transmisie
- e. **Tulburari de echilibru**

50. Tumorile maligne ale hipofaringelui (cancerul de sinus piriform)

- a. **Localizarea cea mai frecventa dintre cancerale hipofaringelui**
- b. Diagnostic: adenopatie laterocervicala tardiva
- c. Senzatie de corp strain, odinofagie, disfagie, otalgie reflexa, hipoacuzie de transmisie
- d. **hipofaringoscopie: laringoscopie indirecta, fibroscopie, esofagoscopie, radiografie cu substant de contrast si CT**
- e. **diagnostic de certitudine- biopsie, tratament: chirurgical, radioterapie, chimioterapie**